위고비·마운자로에 대한 관심은 어떻게 나타나는가



마이쭈 황현종 · 염원 · 이신우 · 박예빈 · 허진범 · 전희원

CONTENTS

목차

01
분석 개요
배경 · 분석 범위 · Q1·Q2

02
데이터 수집 및 점검
데이터 출처와 조회 조건

03
데이터 전처리
데이터 정리 및 비교 기준

04
데이터 분석
기술통계 및 그래프 인사이트

05
분석 결과 및 결론
Q1·Q2에 대한 판정

06
문제점과 해결 방법 및 한계점
분석 과정의 문제 해결과 한계

07
프로젝트 수행 후기

08
Q&A

01

분석 개요

위고비(2024.10)·마운자로(2025.08)가 국내에 잇달아 출시되며 GLP-1 계열 치료제에 대한 관심이 커졌다.

이 관심이 실제 당뇨·비만 진료 및 체중조절 행동과 같은 시기, 같은 지역에서 함께 나타나는지 확인하고자 한다.



분석 범위

1. 건강보험심사평가원 제2형 당뇨(E11)·비만(E66) 연령대별 진료환자 수
2. 네이버 데이터랩 위고비·마운자로 연령대별 검색 상대관심도
3. 지역사회건강조사 시·도별 체중조절 시도율
4. 구글 트렌드 시·도별 위고비·마운자로 검색 상대관심도

분석 기간 2024.01 ~ 2025.12 (24개월)

해석 원칙

1. 네이버 데이터랩 검색 관심도는
   약물·연령대별 최댓값을 100으로 둔 상대지수
   약물 간 높이 대신 정점 시기와 변화 흐름을 비교
2. 위고비·마운자로 비만 처방은 비급여로
   진료환자 수에 집계되지 않으므로 해석에 유의
3. 진료환자 수는 처방이 아닌 질환 진료환자만
   집계된 자료이므로 해석에 유의
4. 구글 트렌드 검색 관심도
   지역 전체 검색 중 해당 약물의 검색 비중을
   최고 지역=100으로 환산한 상대지수
   실제 검색 건수나 지역 인구 규모와 구분하여 해석

Q1 검색 상대관심도가 정점인 달 전후로 진료환자 수는 어떻게 달라지는가?

예상 검색 상대관심도가 높아지는 시기에 제2형 당뇨·비만의 월별 진료환자 수도 증가하는 양상이 나타날 것이다.

Q2 체중조절 시도율과 두 치료제의 검색 상대관심도는 지역별로 어떻게 나타나는가?

예상 체중조절 시도율이 높은 지역에서 같은 연도의 치료제 검색 상대관심도도 높게 나타날 것이다.

02

데이터 수집 과정

분석에 사용한 데이터 — 출처 · 조회 조건 · 기간과 단위

데이터 1 제2형 당뇨·비만 진료환자 수

Q1 · 월별 진료환자 추이

출처	건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템·질병 소분류(3단상병) 통계
조회 조건	상병코드 E11(제2형 당뇨) · E66(비만) | 성별 · 연령 10세 구간
기간 · 단위	2024.01 ~ 2025.12 | 월별 진료환자 수(명)

데이터 2 위고비·마운자로 검색 상대관심도

Q1 · 연령대별 검색 정점 월

출처	네이버 데이터랩 검색어 트렌드 | PC + 모바일
검색어 + 연관어	위고비 · 마운자로 + 다이어트 · 부작용 · 가격 · 병원 · 용량 · 후기 · 효과
연령 구분	~18 · 19~29 · 30대 · 40대 · 50대 · 60~ (6구간 × 2키워드 = 12개 파일)
기간 · 단위	2024.01 ~ 2025.12 | 월별 상대관심도 (기간 내 최댓값 = 100)

데이터 3 지역별 체중조절 시도율

Q2 · 지역별 체중조절 행동

출처	질병관리청「2025 지역사회건강조사 통계집」부록(시도별)
기간 · 단위	2024년 · 2025년 | 전체(표준화율, %)

데이터 4 지역별 검색 상대관심도

Q2 · 지역별 검색 상대관심도

출처	Google Trends 지역별 검색 상대관심도
검색어	위고비, 마운자로
기간	2024.01 ~ 2025.12
단위	16개 시·도 (세종 자료 없음)별 검색 관심도 상대지수(0~100) 지역별 관심도는 각 지역의 전체 검색 중 해당 약물 검색이 차지하는 비중을 계산하고, 그 비중이 가장 높은 지역을 100으로 환산한 값이다.

03

데이터 전처리

분석 단위 통일 → 상대값 변환 → 공통 범위 설정 → 데이터 점검

월·연령 데이터

① 진료환자 수 + ② 검색 관심도

1. 월별 진료환자 수 추출 · 성별 합산
2. 연령 6구간 매핑 (20대 미만 ~ 60대 이상)
3. '-' 2칸 (E66 남성 80세+) → 0 처리
4. 연령대별 상대값 변환 (24개월 최댓값 = 100)
5. 네이버 12개 파일 병합 → ①+② 576행 4열

지역 데이터

③ 체중조절 시도율 + ④ 지역 관심도

1. '14.체중조절' 시트 추출 · 표준오차 표기 제거
2. 전체(표준화율) 행만 사용
3. 세종 제외 16개 시·도 × 2개 연도
4. 구글 트렌드 3개 파일 병합 · 영문 지역명 → 한글 지역명과 매핑
5. ③+④ 병합 → 48행 5열 (16개 시·도 × 3개 구분)

점검 결과

병합 행 수 확인

- ①+② 576행 = 4개 지표 × 6개 연령대 × 24개월
- ③+④ 48행 = 16개 시·도 × 3개 구분

'-' 2칸 → 0 처리 근거

- 건강보험심사평가원 질의응답을 통해 '-' 표기는 산출값 없음을 의미하는 것임을 확인

이상치 처리

- E11 진료환자 수 및 진료환자 상대값이 30대에서 3개월(12.5%), E66 20대 미만에서 2개월(8.33%)이 이상치로 분류
  해당 월의 진료환자 수 변동을 분석에 반영하기 위해 모두 유지
- 2024년 체중조절 시도율에서 전북(60.3%)이 16개 시·도 중 유일한 이상치로 분류(6.25%), 전북을 포함한 지역 간 분포와 순위를 비교하기 위해 유지
- 서울의 상대관심도 100은 2024년 위고비와 2025년 마운자로에서 IQR 기준 이상치로 분류(각 1건, 총 2건), 두 값은 각 그룹의 상대지수 기준점이므로 유지

04

진료환자 수 및 상대값 기술통계

2024.01~2025.12 전체 24개월 기준, 연령대별 관측값 24개 |상대값 = (월별 환자 수 ÷ 해당 질환·연령대의 24개월 최대 환자 수)×100

E11 진료환자 수 기술통계

연령대	mean	std	min	50%	max	iqr	outliers_ ratio(%)	skew
20대 미만	2404.12	172.57	2149.0	2353.5	2769.0	206.75	0.0	0.59
20대	10,800.83	342.87	10059.0	10797.5	11520.0	413.75	0.0	-0.16
30대	41340.29	1368.82	38769.0	41283.5	44173.0	1248.25	12.5	0.13
40대	139214.62	3645.35	131854.0	139800.5	144799.0	5286.75	0.0	-0.26
50대	332866.67	8773.71	314062.0	334527.0	345908.0	14708.75	0.0	-0.34
60대 이상	1052971.88	33471.95	997656.0	1049992.0	1131246.0	47709.50	0.0	0.52

E11 진료환자 상대값 기술통계

연령대	mean	std	min	50%	max	iqr	outliers_ ratio(%)	skew
20대 미만	86.82	6.23	77.61	85.00	100.0	7.47	0.0	0.58
20대	93.76	2.98	87.32	93.73	100.0	3.59	0.0	-0.16
30대	93.59	3.10	87.77	93.46	100.0	2.82	12.5	0.14
40대	96.14	2.52	91.06	96.54	100.0	3.65	0.0	-0.26
50대	96.23	2.54	90.79	96.71	100.0	4.25	0.0	-0.34
60대 이상	93.08	2.96	88.19	92.82	100.0	4.22	0.0	0.52

E66 진료환자 수 기술통계

연령대	mean	std	min	50%	max	iqr	outliers_ ratio(%)	skew
20대 미만	399.67	93.76	232.0	384.0	608.0	98.50	8.33	0.64
20대	541.71	112.30	407.0	481.5	772.0	185.75	0.0	0.69
30대	1051.83	287.14	710.0	905.0	1658.0	465.75	0.0	0.73
40대	1096.38	236.98	852.0	974.5	1535.0	384.50	0.0	0.78
50대	704.12	162.67	545.0	627.5	1000.0	274.00	0.0	0.74
60대 이상	349.79	84.07	240.0	313.0	496.0	122.50	0.0	0.60

E66 진료환자 상대값 기술통계

연령대	mean	std	min	50%	max	iqr	outliers_ ratio(%)	skew
20대 미만	65.73	15.42	38.16	63.16	100.0	16.20	8.33	0.64
20대	70.17	14.55	52.72	62.37	100.0	24.06	0.0	0.69
30대	63.44	17.32	42.82	54.58	100.0	28.09	0.0	0.73
40대	71.42	15.44	55.50	63.48	100.0	25.06	0.0	0.78
50대	70.41	16.27	54.50	62.75	100.0	27.40	0.0	0.74
60대 이상	70.52	16.95	48.39	63.10	100.0	24.70	0.0	0.60

점검

- E11 30대의 진료환자 수, 진료환자 상대값 기술통계 모두 3개월(12.5%)이 이상치로 분류
- E66 20대 미만의 진료환자 수, 진료환자 상대값 기술통계 모두 2개월(8.33%)이 이상치로 분류
- 해당 월의 진료환자 수 변동을 분석에 반영하기 위해 모두 유지

한계

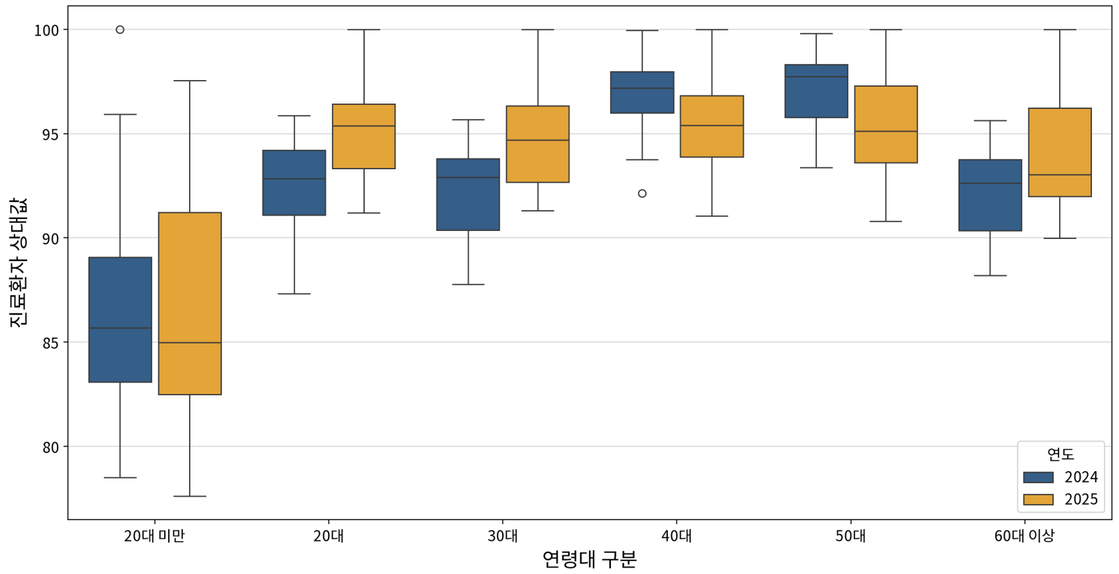
- 상대값 기술 통계는 상대지수(0~100)로 정규화되어 실제 환자 수의 절대적 규모를 파악하기 힘듦
- 연령대별 전체 인구 수 자료가 없어 인구 대비 환자 비율은 계산할 수 없음

04

연령 구분에 따른 연도별 진료환자 상대값 분포

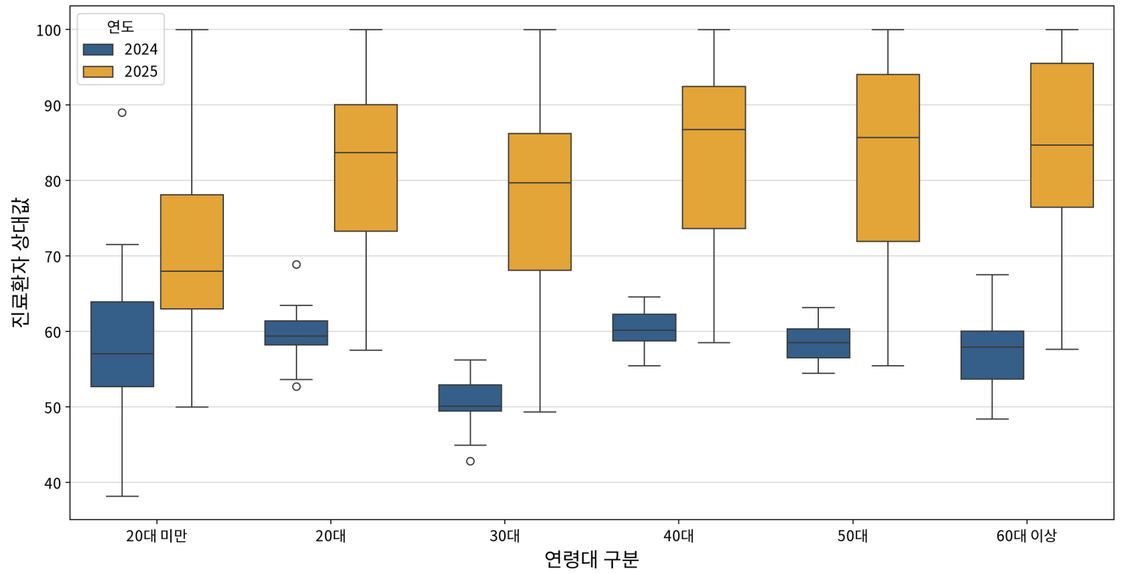
Q1 · 2024, 2025 연도별 분포 (연령대별 24개월 최댓값 = 100) | 상대값 = (월별 환자 수 ÷ 해당 질환·연령대의 24개월 최대 환자 수)×100

연령대 구분에 따른 E11(제2형당뇨) 진료환자 상대값 분포



- 두 해의 IQR이 연령대별로 일부 겹치며, 중앙값 변화의 방향도 연령대마다 다름
- 20대 미만 연령대에서 타 연령대 대비 IQR을 포함한 전체 범위가 넓게 분포하여 해당 집단의 최고점 대비 월별 진료환자 수 변화가 상대적으로 크게 나타남
- 상대값의 최댓값 100은 20대 미만을 제외한 전 연령대에서 2025년에 나타났으나 20대 미만은 2024년에 이상치로 확인됨

연령대 구분에 따른 E66(비만) 진료환자 상대값 분포



- 모든 연령대에서 2025년 월별 진료환자 상대지수의 중앙값이 2024년보다 높게 나타남
- 2024년 대비 2025년 상대지수는 모든 연령대에서 중앙값이 상승했지만 20대 미만의 상승 폭은 다른 연령대보다 작음
- 2024년 대비 2025년 IQR이 확대되었으며 상대지수가 전년보다 넓은 범위에 분포됨

한계

- Y축이 진료환자 상대값(최댓값 100 기준)으로 정규화되어 있어, 각 연령대별 실제 환자 수의 절대적 규모를 알 수 없음
- 관측된 이상치의 원인을 이 그래프만으로는 식별하기 어려움
- 연령대별 표본(연령대별 진료환자 수)의 개수나 전체 집단 크기 정보를 이 그래프로 확인하기 어려움

04 위고비·마운자로 상대관심도 및 체중조절 시도율 기술통계

2024년 위고비 기술통계 (네이버 데이터랩)

	mean	std	min	50%	max	iqr	outliers_ratio(%)	skew
상대관심도	13.13	19.94	0.69	3.91	100.0	14.5	9.72	2.66

2025년 위고비 기술통계 (네이버 데이터랩)

	mean	std	min	50%	max	iqr	outliers_ratio(%)	skew
상대관심도	50.81	23.91	13.88	46.44	100.0	35.24	0	0.55

마운자로 출시 전(19개월) 기술통계 (네이버 데이터랩)

	mean	std	min	50%	max	iqr	outliers_ratio(%)	skew
상대관심도	1.68	2.02	0.16	0.83	10.44	1.45	7.89	2.58

마운자로 출시 후(5개월) 기술통계 (네이버 데이터랩)

	mean	std	min	50%	max	iqr	outliers_ratio(%)	skew
상대관심도	79.38	16.23	43.31	77.15	100.0	26.3	0	-0.26

2024년 위고비 상대관심도(구글 트렌드)·체중조절시도율 기술통계

	mean	std	min	50%	max	iqr	outliers_ratio(%)	skew
체중조절시도율	65.41	2.31	60.3	65.65	69.8	2.25	6.25	-0.35
상대관심도	56.75	15.91	39.0	52.50	100.0	22.00	6.25	1.29

2025년 위고비 상대관심도(구글 트렌드)·체중조절시도율 기술통계

	mean	std	min	50%	max	iqr	outliers_ratio(%)	skew
체중조절시도율	69.41	2.59	64.7	69.75	74.5	2.58	0.0	-0.24
상대관심도	74.62	11.48	58.0	71.50	100.0	19.00	0.0	0.67

2025년 마운자로 상대관심도(구글 트렌드)·체중조절시도율 기술통계

	mean	std	min	50%	max	iqr	outliers_ratio(%)	skew
체중조절시도율	69.41	2.59	64.7	69.75	74.5	2.58	0.0	-0.24
상대관심도	67.38	13.28	52.0	64.00	100.0	16.75	6.25	1.24

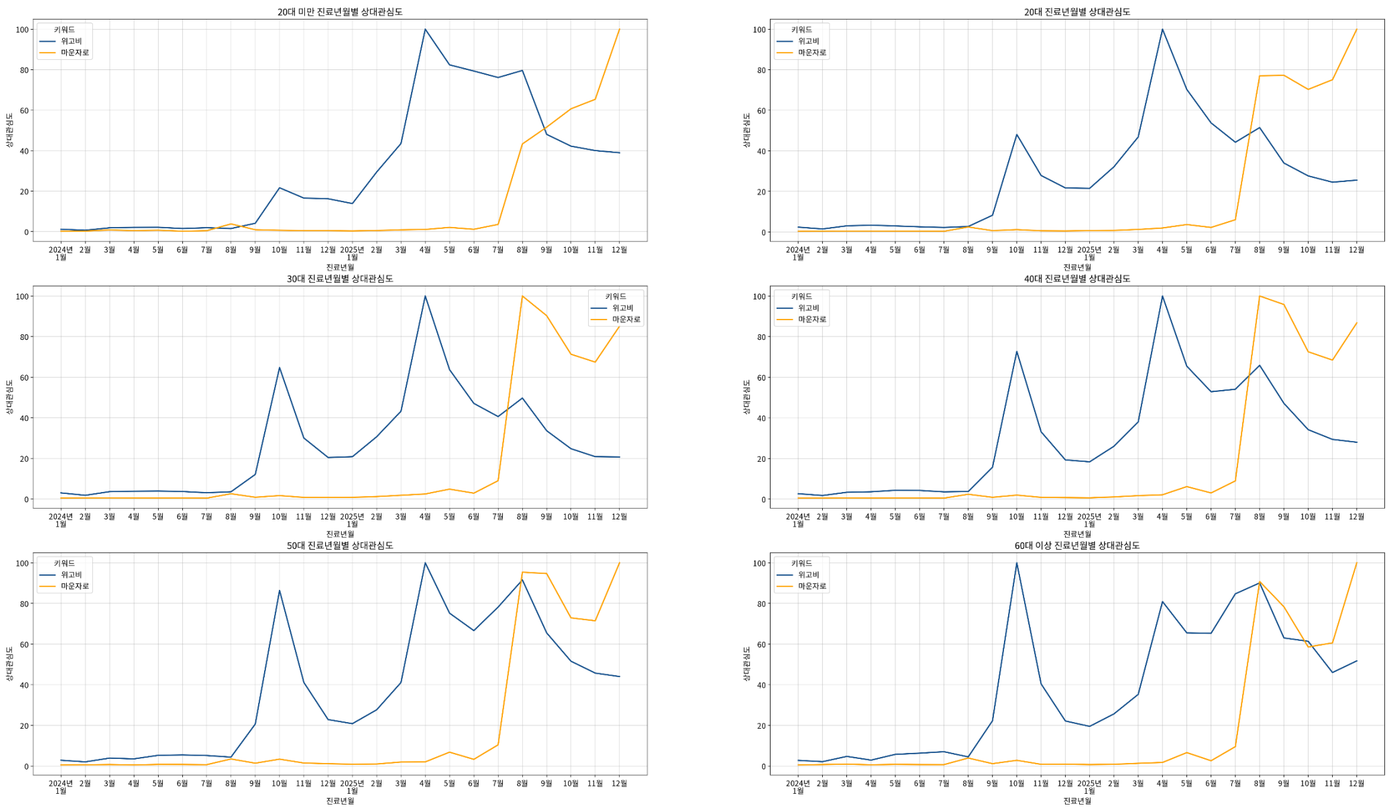
- 위고비 상대관심도는 2024년 중앙값 3.91에서 2025년 46.44로 올랐고 다섯 연령대가 2025년 04월에 최고점(100)을 찍었음
- 마운자로 상대관심도는 국내 출시(2025년 08월) 전 19개월 동안 최대 10.44에 그쳤고 국내 출시 후 5개월의 중앙값은 77.15 였음

- 2024년의 지역별 체중조절 시도율은 평균과 중앙값이 유사하고, 분포의 치우침이 크지 않음
- 2025년의 지역별 체중조절 시도율의 평균과 중앙값이 2024년보다 높아짐
- 2025년 마운자로 관심도는 서울(100)·경기(90)가 가장 높고 제주(52)·경남(55)이 가장 낮음

04

연령대별 위고비·마운자로 상대관심도

Q1 · 연령대별 검색 관심도 (네이버 데이터랩, 키워드·연령대별 최댓값 = 100)



1 **정점 시기**
위고비 2024년 10월·2025년 4월
마운자로 2025년 8월·2025년 12월
※ 위고비 국내 출시 2024년 10월 | 마운자로 국내 출시 2025년 8월

2 **위고비 정점**
60대 이상만 2024년 10월 정점, 나머지 연령대는 2025년 4월 정점

3 **마운자로 정점**
30·40대는 2025년 8월, 나머지 연령대는 2025년 12월에 정점

4 **마운자로 출시 이후의 추세**
2025년 8월 이후 마운자로는 높은 수준을 유지한 반면,
위고비는 하락세

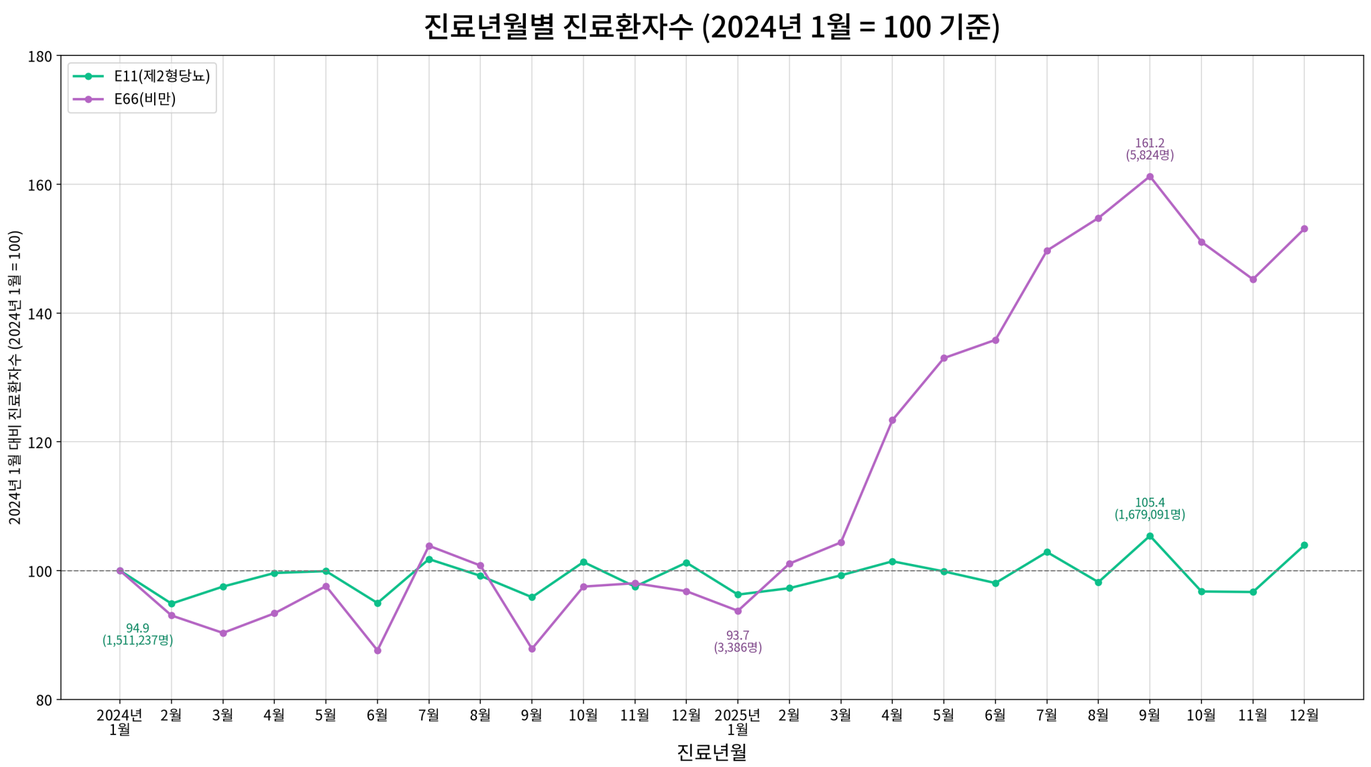
한계

- 검색 관심도가 상대지수이기 때문에 실제 검색 건수를 알 수 없고 조회한 연도·구분의 수치를 직접 비교하기 어려움
- 위고비·마운자로에 대한 검색 관심도가 실제 처방 구매 사용 등으로 연결되었는지 알 수 없음
- 네이버 플랫폼에서 나타난 관심도이므로 전체 인구의 관심으로 일반화하기 어려움

04

진료년월별 E11·E66 진료환자 수

Q1 · 월별 진료환자 수 추이 (건강보험심사평가원, 전 연령 합산)



1 **E66 (비만)**
2025년 1월 이후 급증하며 2025년 9월이 최고점 (1월 대비 약 72% 상승)

2 **E11 (제2형 당뇨)**
전체적으로 등락을 반복함 (최솟값과 최댓값 약 11% 차이)

3 **최고점 시기**
E11·E66 모두 최고점이 2025년 9월로 동일한 모습

4 **두 지표의 흐름 비교**
2024년엔 E11·E66이 비슷하게 오르내렸지만
2025년엔 E66만 전반적으로 증가

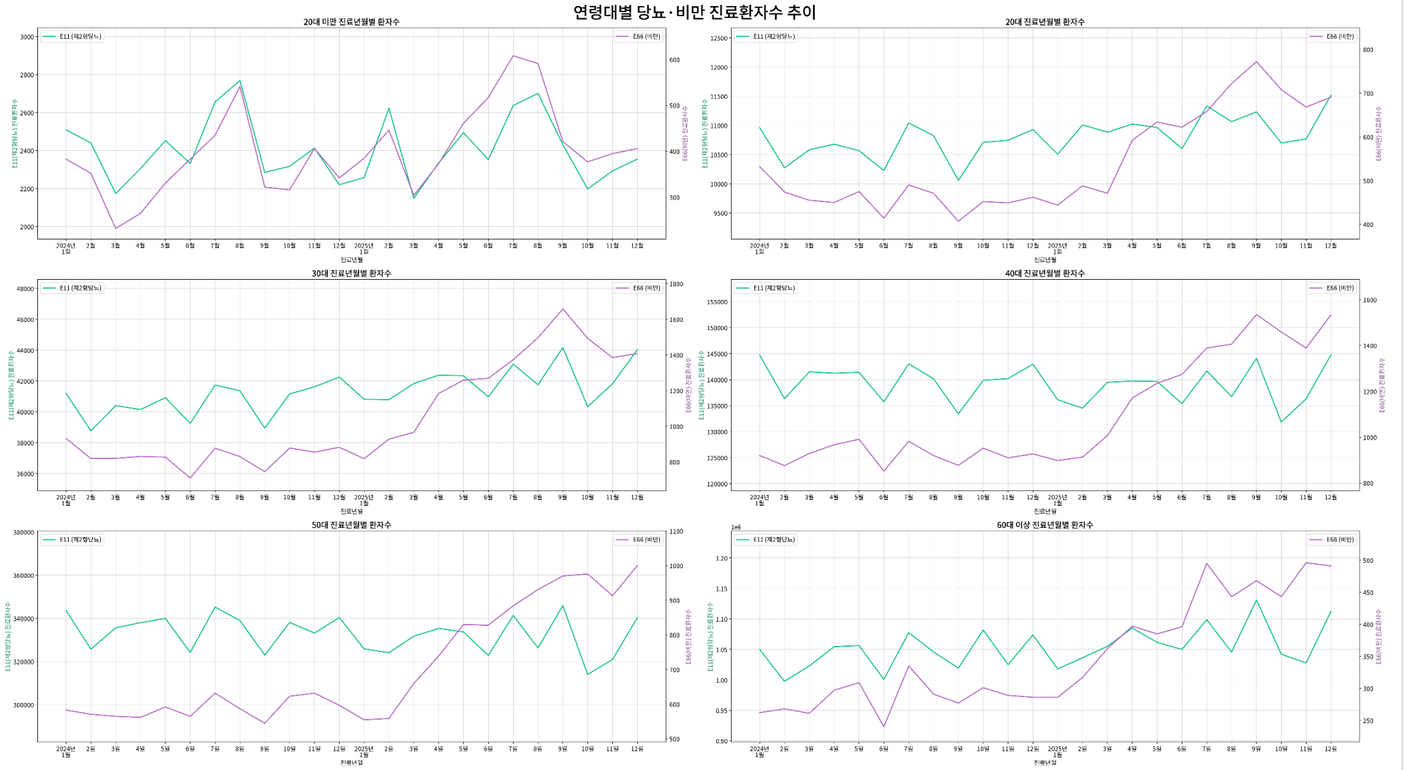
한계

- 건강보험심사평가원에서 진료환자 수를 집계한 데이터이므로 질환 보유자의 전체를 의미하지 않음
- 위고비·마운자로의 치료 처방은 건강보험 비급여라 자료에 잡히지 않음
- 모든 연령대를 더한 집계이므로 모든 연령대가 같은 추세라고 판단하기 어려움

04

연령대별 진료년월별 당뇨·비만 진료환자 수

Q1 · 연령대별 진료환자 수 추이 (60대 이상 = 60·70·80대 이상 합산)



1 **E11**

60대 이상의 환자 수가 백만 단위로 다른 연령대에 비해 매우 높고, 모든 연령대에서 증감을 반복함

2 **E66**

모든 연령대에서 2025년 이후 증가하는 모습이 보임

3 **20대 미만**

07월, 08월 진료환자 수가 높아졌다가 이후 감소하는 모습이 두 해 공통으로 보임

4 **연도별 지표 흐름**

2024년에는 전반적으로 E11과 E66의 진료환자 수가 비슷한 흐름으로 오르내린 반면 2025년 E66 진료환자 수가 전반적으로 증가하며 두 지표 흐름에 차이를 보임

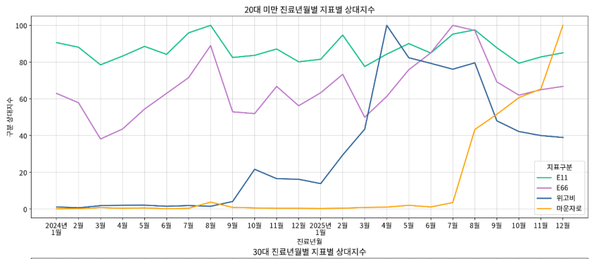
한계

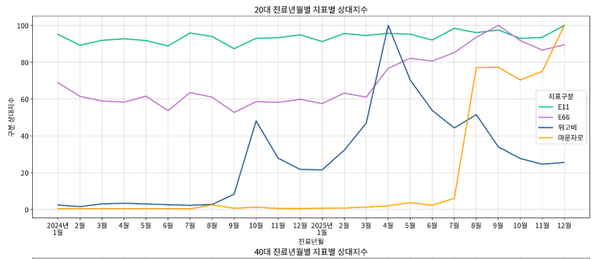
- 연령대마다 전체 인구수가 달라서 진료환자 수가 많다는 이유만으로 해당 연령대에서 질병이 더 흔하게 나타난다고 판단하기 어렵다.
- 연령대별 세로축 범위가 달라 선의 변동성을 그대로 비교하기 어렵다.

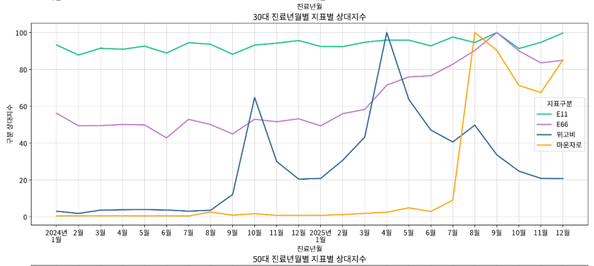
04

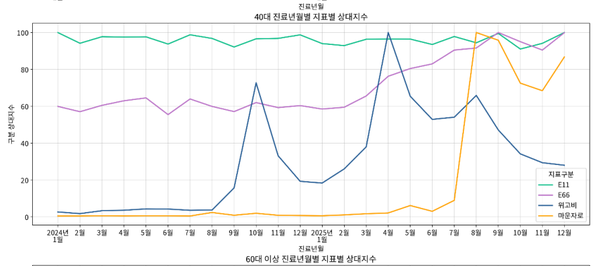
연령대별 시간의 흐름에 따른 지표별 상대지수

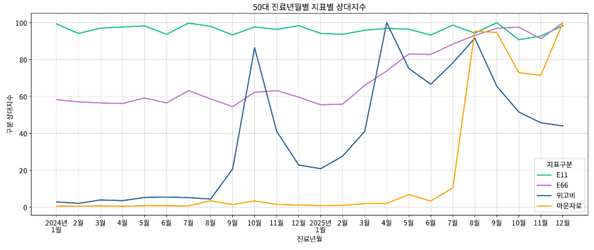
Q1 · 진료환자 상대지수(E11·E66) × 검색 관심도(위고비·마운자로)

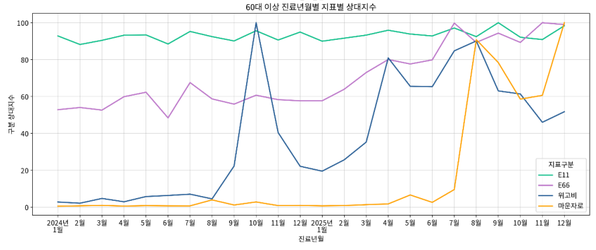








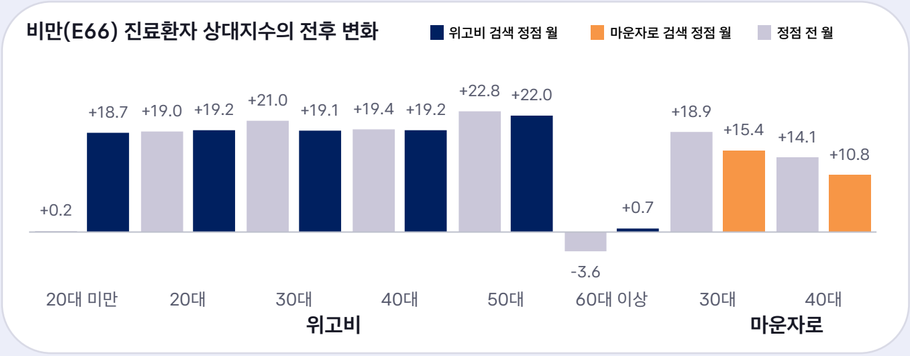




※ 연령대별 위고비·마운자로 상대관심도 인사이트는 p.9에서 다뤄 생략

1 검색 정점 전후의 비만 진료환자 지수 변화

- 위고비 20대 미만은 정점 월 기준 +18.7, 정점 전 월 기준 +0.2로 차이가 큰 반면 20~50대에서는 정점 월과 그 전 월을 기준으로 계산한 상승 폭이 비슷했다.
- 마운자로 30·40대는 정점 월 대비 정점 전 월 상승 폭이 더 컸다.



기준 월을 제외한 직후 2개월 평균 – 직전 2개월 평균
정점 월은 위고비 2025년 4월(60대 이상은 2024년 10월), 마운자로 2025년 8월
마운자로 4개 연령대는 2025년 12월이 정점으로, 이후 2개월 자료가 없어 제외

2 E11

20대 미만 제외 모든 연령대가
87~100으로 고점 유지

3 E66

20대 이상의 연령대에서 2025년 2월부터 상승
위고비 4월 정점(5개 연령대)·마운자로 8월 급증 이전

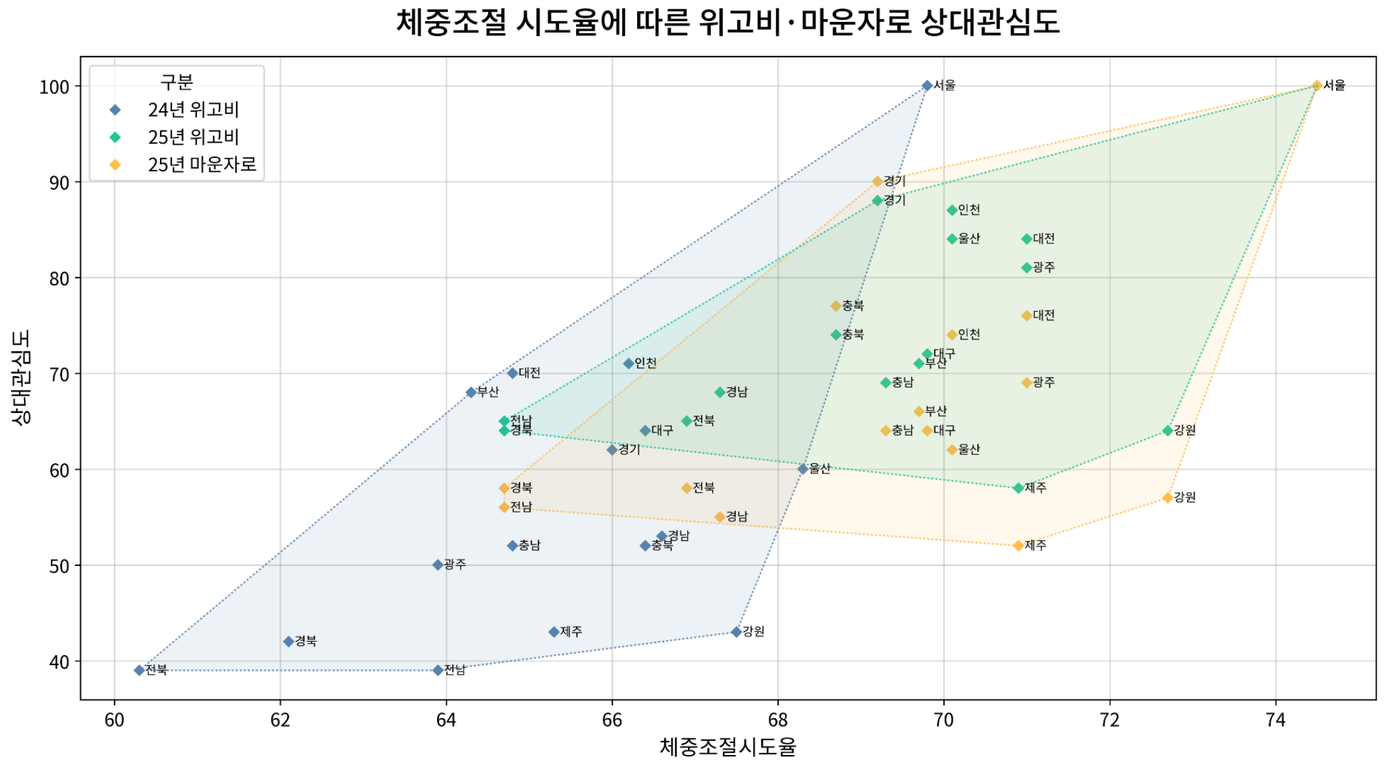
한계

- 지표 간 수치 차이를 실제 검색 건수나 진료환자 수의 규모 차이로 해석할 수 없음
  따라서 정점 시기와 상승·하락 흐름을 중심으로 비교
- 서로 다른 기관이 집계한 자료이므로, 검색한 사람이 실제 진료받은 사람이라고 해석하기 어려움

04

체중조절 시도율에 따른 위고비·마운자로 상대관심도

Q2 · 시·도별 산점도 (상대관심도 서울 = 100 기준 · 세종 제외 16개 시·도)



1 **서울**
모든 구분에서 체중조절 시도율과 상대관심도 모두 1위

2 **강원·제주**
2025년 체중조절 시도율은 상위권(2위·5위)이지만
상대관심도는 하위권 (위고비 14·16위, 마운자로 13·16위)

3 **분포**
모든 구분에서 상대관심도 하위 5곳은 모두 도 지역인 반면,
대도시는 높은 수치를 보여줌

4 **2024 → 2025**
16개 시·도 모두 체중조절 시도율 상승. 위고비는 서울과 다른 지역의 격차가 줄었음 (서울 대비 비율, 절대 증가 아님)

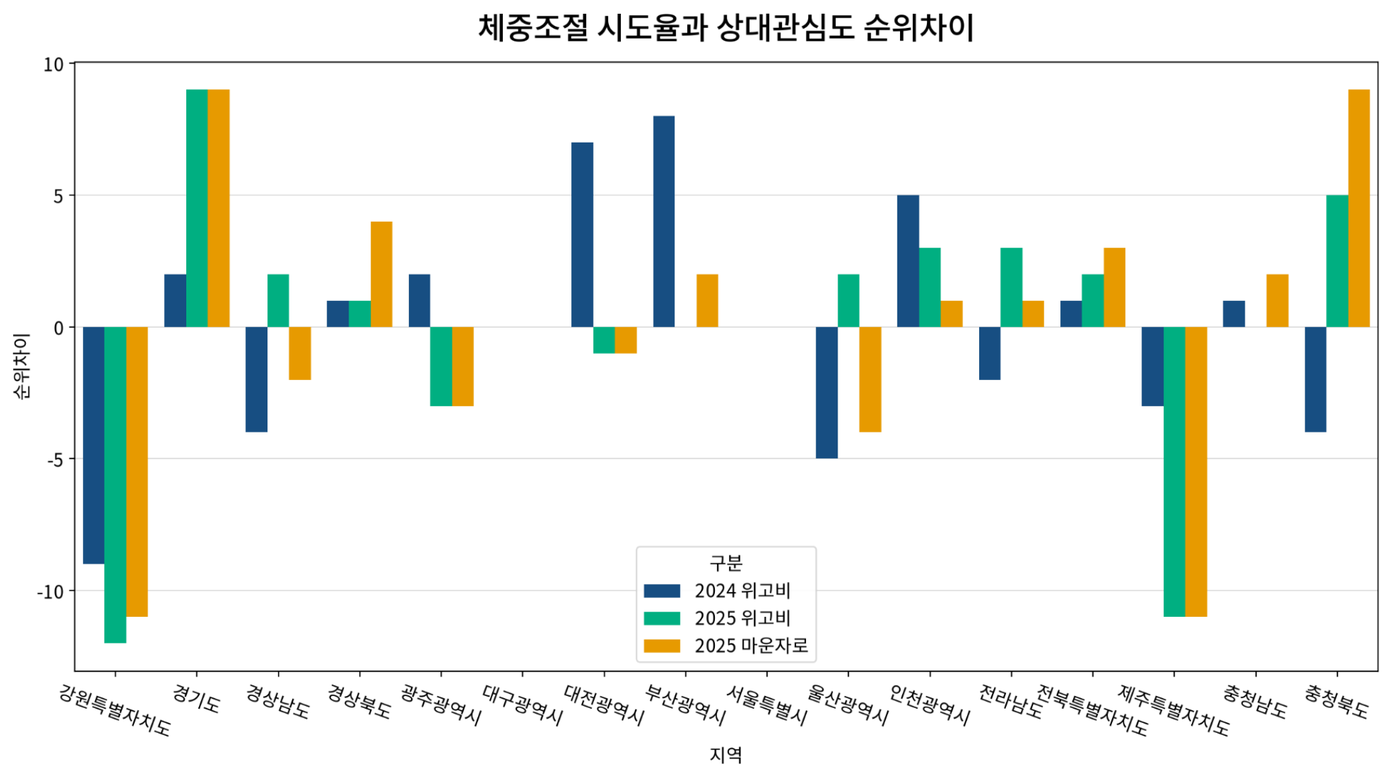
한계

- 마운자로는 24년 자료가 없기 때문에 시간의 흐름에 따른 지표 변화를 비교할 수 없음
- 세종시에 대한 검색 관심도 자료가 없어 공통 자료가 확보된 16개 지역의 데이터만 사용
- 체중조절 시도율 조사에 응답한 사람과 검색 상대관심도의 대상이 일치하지 않아 지역 분포와 관계를 살펴보는 자료로만 사용할 수 있음
- 모든 지표에서 서울이 가장 높다는 사실만으로 서울에서는 체중조절 시도가 치료제 검색으로 이어졌다고 판단할 수 없음

04

지역별 순위 차이 비교

순위 차이 = 체중조절 시도율 순위 − 상대관심도 순위 · 2024 위고비 / 2025 위고비 / 2025 마운자로



1 **강원·제주**
세 구분 모두 음의 방향으로 순위 차이가 크게 나타남

2 **충북**
2024 위고비 −4에서 2025 위고비 +5, 마운자로 +9로 양수로 전환됨

3 **경남·울산**
2024 위고비는 음수, 2025 위고비는 양수,
2025 마운자로는 음수로 구분에 따라 방향이 다름

4 **서울·대구**
두 지역의 경우 세 구분 모두 0으로 나타나
체중조절 시도율과 상대관심도 순위 차이가 같음

5 **경기**
위고비의 순위 차이가 2024년 +2에서 2025년 +9로 증가하였으며, 2025년 마운자로도 +9로 상대관심도 순위가 시도율 순위보다 높음

한계

- 순위 차이가 0이어도 두 순위가 상위인지 중·하위인지는 알 수 없음 (서울 1위·1위, 대구 2025년 8위·8위)
- 연도 간 막대 변화가 시도율 순위 때문인지 관심도 순위 때문인지는 이 그래프로 구분되지 않음

04

연도별 순위 차이 지도 (QGIS)

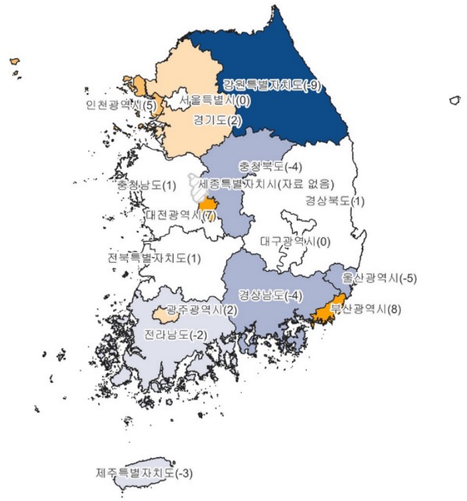
순위 차이 = 체중조절 시도율 순위 − 상대관심도 순위 · 2024 위고비 / 2025 위고비 / 2025 마운자로

상대관심도와 체중조절 시도율 순위차이

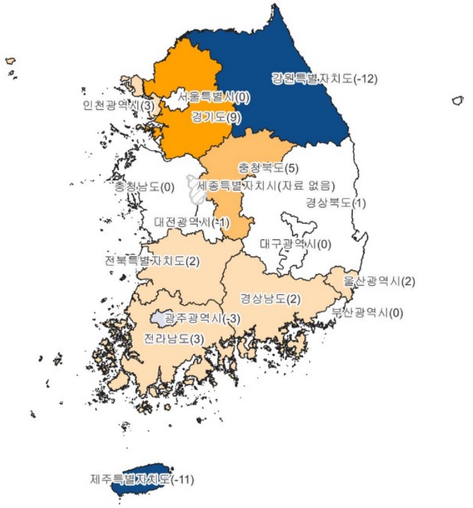
순위차이:
(체중조절 시도율 순위
- 상대관심도 순위)

- 7 – 12
- 4 – 6
- 2 – 3
- −1 – 1
- −3 – −2
- −6 – −4
- −13 – −7

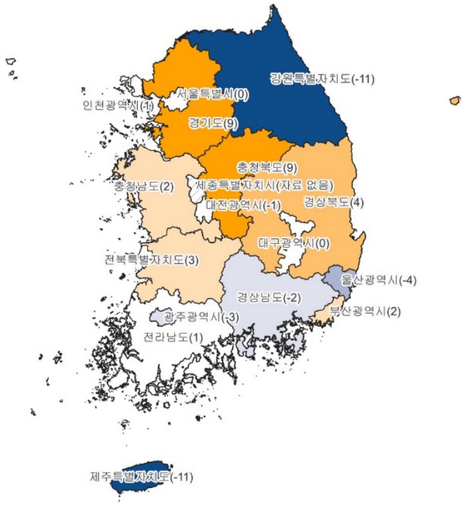
24년 위고비



25년 위고비



25년 마운자로



1 강원·제주

강원은 모든 지표에서 체중조절 시도율 순위가 상대관심도 순위보다 높음.
제주는 위고비 순위 차이가 −3 → −11로 벌어지고 마운자로도 −11

2 대전·부산

위고비 순위 차이가 대전은 +7 → −1, 부산은 +8 → 0으로 변해 두 지표의 순위가 가까워짐

한계

- **순위 차이는 두 지표의 순위 차이만 보여줄 뿐 원인까지는 파악할 수 없음**

05 분석 결과 및 결론

Q1. 검색 상대관심도가 정점인 달 전후로 진료환자 수는 어떻게 달라지는가?

예상 : 검색 상대관심도가 높아지는 시기에 제2형 당뇨·비만의 월별 진료환자 수도 증가하는 양상이 나타날 것이다.

2025년 비만 진료는 꾸준히 늘었지만, 제2형 당뇨 진료는 거의 변하지 않았다.

판단 보류

예상 ① · 비만

- 위고비 20대 미만은 정점 월 기준 +18.7, 정점 전 월 기준 +0.2로 차이가 큰 반면 20~50대에서는 정점 월과 그 전 월을 기준으로 계산한 상승 폭이 비슷했다.
- 마운자로 30·40대에서는 정점 전 월 기준 상승 폭이 더 컸다.
- 비만 진료환자 수는 2025년 1월부터 전반적으로 증가했으며, 검색 정점이 아닌 월을 기준으로 비교해도 비슷한 증가가 나타났다.

2025년 비만 진료는 1월부터 전반적으로 늘어
검색 정점과 같은 시기에 늘었는지는 이 비교로 판단할 수 없다.

불일치

예상 ① · 제2형 당뇨

- 검색 상대관심도 정점 월 기준 E11 진료환자 상대지수 차이는 모든 집단에서 상대지수 -1.4~+1.5 이내였다.
- 검색 상대관심도 정점 전 월 기준 E11 진료환자 상대지수 차이는 모든 집단에서 상대지수 -0.9~+3.5 이내였다.
- 두 해의 분포가 모든 연령대에서 겹쳤다.

검색 상대관심도의 정점 전후를 비교한 결과, 제2형 당뇨 진료환자 수의 일관된 증가는 확인되지 않았다.

05

Q1. 검색 상대관심도가 정점인 달 전후로 진료환자 수는 어떻게 달라지는가?

연령대별 검색 정점 월 앞 2개월 평균과 뒤 2개월 평균 비교 (후 – 전)

검색 정점 전후 진료환자 상대지수 변화

약물	연령대	정점 월	E11 (정점 월 기준)	E66 (정점 월 기준)	정점 전 월	E11 (정점 전 달 기준)	E66 (정점 전 달 기준)
위고비	20대 미만	2025-04	+1.3	**+18.7**	2025-03	−0.9	+0.2
	20대	2025-04	−1.4	**+19.2**	2025-03	+2.1	**+19.0**
	30대	2025-04	+0.8	**+19.1**	2025-03	+3.5	**+21.0**
	40대	2025-04	+0.4	**+19.2**	2025-03	+3.0	**+19.4**
	50대	2025-04	+0.1	**+22.0**	2025-03	+2.8	**+22.8**
	60대 이상	2024-10	+1.5	+0.7	2024-09	−0.7	−3.6
마운자로	30대	2025-08	+0.5	**+15.4**	2025-07	+3.0	**+18.9**
	40대	2025-08	−0.4	**+10.8**	2025-07	+2.0	**+14.1**

핵심 인사이트

1. **E66, 위고비 20대 미만**
   정점 월 기준에서 E66은 +18.7
   정점 전 월 기준에서 +0.2로 큰 차이를 보임
2. **E66, 위고비 20~50대**
   정점 월 기준에서 E66은 +19.1~+22.0
   정점 전 월 기준에서 +19.0~+22.8로 상승폭이 비슷함
3. **E66, 마운자로 30·40대**
   정점 월 기준에서 E66은 +10.8~+15.4
   정점 전 월 기준에서 +14.1~+18.9로 상승폭이 더 컸음
4. **E11**
   정점 월 기준에서 E11은 모두 ± 1.5 이내,
   정점 전 월 기준에서 모두 -0.9~+3.5 이내였음

비교 기준

- 연령대별 정점 월과 정점 직전 월을 각각 기준으로, 기준 월을 제외한 직후 2개월 평균에서 직전 2개월 평균을 뺀 값(진료환자 상대지수, 연령대별 24개월 최댓값 = 100)
- 정점이 2025-12인 연령대(마운자로 20대 미만, 20대, 50대, 60대 이상)는 정점 뒤 자료가 없어 판정에서 제외
- 표의 보라색 = E66 상승 +10 이상

05 분석 결과 및 결론

Q2. 체중조절 시도율과 두 치료제의 검색 상대관심도는 지역별로 어떻게 나타나는가?

예상 : 체중조절 시도율이 높은 지역에서 같은 연도의 치료제 검색 상대관심도도 높게 나타날 것이다.

체중조절 시도율이 높은 지역에서 치료제 검색 상대관심도가 높게 나타난 것만은 아니었다.

부분 일치

예상 ② · 지역

- 서울은 시도율·관심도 모두 1위로 예상과 일치했다.
- 강원·제주는 시도율 상위·관심도 하위,
  경기는 시도율 11위·관심도 2위로 반대였다.

16개 시·도 중 8~9곳은 두 순위가 비슷했지만
강원·제주는 시도율 상위·관심도 하위, 경기·충북은 그 반대로 크게 어긋났다.

05

Q2. 체중조절 시도율과 두 치료제의 검색 상대관심도는 지역별로 어떻게 나타나는가?

구분별 체중조절 시도율과 관심도 순위 차이 비교

시·도별 체중조절 시도율 순위와 검색 관심도 순위

지역	2024 위고비			2025 위고비			2025 마운자로		
	시도율	관심도	차이	시도율	관심도	차이	시도율	관심도	차이
서울	1	1	0	1	1	0	1	1	0
강원	3	12	−9	2	14	−12	2	13	−11
대전	10	3	+7	3	4	−1	3	4	−1
광주	13	11	+2	3	6	−3	3	6	−3
제주	9	12	−3	5	16	−11	5	16	−11
인천	7	2	+5	6	3	+3	6	5	+1
울산	2	7	−5	6	4	+2	6	10	−4
대구	5	5	0	8	8	0	8	8	0
부산	12	4	+8	9	9	0	9	7	+2
충남	10	9	+1	10	10	0	10	8	+2
경기	8	6	+2	11	2	+9	11	2	+9
충북	5	9	−4	12	7	+5	12	3	+9
경남	4	8	−4	13	11	+2	13	15	−2
전북	16	15	+1	14	12	+2	14	11	+3
전남	13	15	−2	15	12	+3	15	14	+1
경북	15	14	+1	15	14	+1	15	11	+4

핵심 인사이트

강원·제주는 세 비교 모두 시도율 순위가 관심도 순위보다 높았고(−3~−12), 2025년 경기·충북은 반대로 관심도 순위가 최대 9칸 높았다.

2 / 16

세 비교 모두 음수 (강원·제주)

+9

2025 최대 양수 (경기·충북)

비교 기준

- 순위 차이 = 체중조절 시도율 순위 − 검색 관심도 순위 (같은 연도끼리 비교, 16개 시·도, 세종 제외)
- 음수 = 시도율 순위가 더 높음, 양수 = 관심도 순위가 더 높음 (동점은 같은 순위)
- 표의 파랑 = −5 이하, 주황 = +5 이상 · 지역은 2025 시도율 순위순

06

문제점과 해결 방법 및 한계점

분석 과정에서 부딪힌 문제와 해결 방법, 남은 한계

문제점

1 지표마다 기준이 다름

검색 지수는 키워드·연령대별로 최댓값=100, 진료환자 수는 연령대별 규모 차이가 큼 (E11 60대 이상 월 약 105만 명 vs 20대 미만 약 2,400명)

2 자료 범위가 서로 다름

연령 구간 차이(심평원 10세 구간 vs 네이버 ~18·19~29세), 마운자로 2024 지역 자료는 7개 시·도만 값, 세종 자료 없음

3 결측 '-' 표기

E66 남성 80세 이상 2024.02·2024.10 두 달이 '-'로 표기

해결 방법

상대값으로 맞춰 흐름 비교

연령대별 24개월 최댓값=100으로 변환, 키워드끼리는 높이 대신 정점·최저 시기만 비교

공통 범위로 정리

연령 6구간 매핑, 마운자로 2024 제외(2025.08 국내 출시), 세종 제외 16개 시·도로 분석

근거를 확인하고 0 처리

건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 https://opendata.hira.or.kr에서 질의응답을 통해 산출값 없음을 확인

한계점

1. 위고비·마운자로 비만 처방은 비급여라 진료 자료에 잡히지 않아, 검색이 실제 처방·진료로 이어졌는지 알 수 없다
2. 검색 지수는 상대값(최댓값·서울=100)이라 절대 검색량을 모르고, 검색한 사람과 진료받은 사람이 같은지 확인할 수 없다
3. 2025년 비만 진료의 전반적 상승과 검색 정점의 영향을 구분할 수 없으며, 관찰된 관계는 인과가 아니다
4. 체중조절 시도율(연 1회 표본조사)과 검색 관심도는 대상·집계 기간이 달라 지역 순위 비교까지만 가능하다

07 프로젝트 수행 후기

황현종

주제를 잡고 데이터를 고르는 과정에서 우리가 구할 수 있는 데이터의 범위, 데이터의 형태 등 여러 어려움이 있었지만 팀원들과 의견을 나누고 토론하며 타협안을 찾고 방향성을 조율해 나갈 수 있었습니다.
이 과정을 통해 단순히 완벽한 주제를 찾는 것보다, 주어진 자원 안에서 의미 있는 인사이트를 도출하는 것이 더 중요하다는 것을 깨달았습니다.

염원

데이터를 점검하고 전처리하며 시각화 결과를 완성하기까지의 과정이 때로는 지난하게 느껴졌지만, 하나씩 문제를 해결해 나가는 과정은 나름대로 재미있기도 했습니다. 무엇보다 좋았던 것은 우리가 하나의 팀으로서 결과물을 만들어갈 수 있었다는 점입니다. 이번에 발표를 맡게 된 만큼 우리가 함께 고민하고 노력했던 과정들이 모두에게 잘 전달될 수 있었으면 좋겠습니다.

이신우

이번 프로젝트를 통해 데이터 전처리와 시각화 과정의 중요성을 배우고, 분석 결과를 다양한 관점에서 해석하는 경험을 할 수 있었습니다.
팀원들과 역할을 분담하고 의견을 공유하며 문제를 함께 해결하는 과정에서 협업의 중요성을 느낄 수 있었습니다.

박예빈

필요한 데이터를 찾고, 자료마다 다른 기준을 맞추는 데 생각보다 시간이 많이 걸렸습니다. 그래프를 만드는 것보다 그 안에서 인사이트를 발굴하는 것이 더 어려웠습니다.
혼자 분석했다면 놓쳤을 부분을 서로 짚어줄 수 있다는 점에서 협업의 중요성을 느꼈습니다.

허진범

주제 선정과 데이터 수집에서 많이 헤맸지만, 구할 수 있는 데이터 안에서 방향을 다시 잡는 경험을 했습니다. 팀원들과 함께 점검하며 코드와 모듈, 데이터를 깊이 이해했고, 계획부터 인사이트까지가 하나의 흐름이라는 것을 배웠습니다.

전희원

처음에는 분석 방향을 잡는 데 어려움이 있었지만, 팀원들과 의견을 나누며 조금씩 결과를 만들어 가는 과정이 인상 깊었습니다. 여러 자료를 그래프로 정리하고, 그 안에서 발견한 내용을 직접 설명할 수 있게 된 점이 가장 뿌듯했습니다.

경청해주셔서 감사합니다!

Q & A

